7주차 takehome

현재 진단하는 정신병리 진단은 과잉진단인가?

문제상황 - 최근 우울증, 성인 ADHD 등의 정신장애에 대한 허들이 낮아지면서 많은 이들이 진단을 통해 약이나 치료를 병행한다. 이를 진단하는 진단체계인 DSM은 증상개수와 기간이 핵심이 되는 체크리스트형식으로 맥락 고려는 부차적이다.

과잉진단은 약물 오남용(경미한 경우까지 약물처방 확대), 낙인효과(자기개념 제한 및 사회평가 변화), 정상경험의 병리화(인간의 보편 경험이 문제로 재정의됨), 자기조절능력 약화(모든 고통을 외부의 치료로 해결하려는 태도) 등에서 문제가 된다.

→ 이러한 진단의 증가의 원인은 과잉진단인가 혹은 실제 유병률의 증가인가

*맥락 고려 진단은 과잉진단의 기준으로 활용

Cheng N, Bryce S, Takagi M, Pert A, Rattray A, Fisher E, Lai M, Geljic M, Youn S, Wood SJ, Allott K. The Prevalence of Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Psychotic Disorders: Systematic Review and Meta-analysis. Schizophr Bull. 2025 Nov 10;51(6):1514-1528. doi: 10.1093/schbul/sbae228. PMID: 39800829; PMCID: PMC12599807.

https://www.theguardian.com/society/article/2024/jul/26/record-numbers-in-england-taking-adhd-medication-nhs-data-shows?CMP=share_btn_url

Moreno-Agostino D, Wu YT, Daskalopoulou C, Hasan MT, Huisman M, Prina M. Global trends in the prevalence and incidence of depression:a systematic review and meta-analysis. J Affect Disord. 2021 Feb 15;281:235-243. doi: 10.1016/j.jad.2020.12.035. Epub 2020 Dec 9. PMID: 33338841.

⇒우울증 및 ADHD 진단이 증가했다는 근거

핵심가치 : 정상성의 기준

정상범위를 넓게 봐야한다, 다양한 감정과 행동은 인간의 자연스러운 스펙트럼이다 그러므로 맥락을 포함해야한다 vs 기능손상(증상)이 있다면 비정상이며 병리이다

Horwitz, A. V., & Wakefield, J. C. (2007). *The loss of sadness: How psychiatry transformed normal sorrow into depressive disorder.* Oxford University Press.
⇒ 정상적인 슬픔까지 우울증으로 오인. 슬픔은 맥락적이고 적응적 감정인데 현재 진단은 이 맥락을 충분히 고려하지 않음. → 정상감정의 병리화.

한국어번역

Frances, A. (2013). *Saving normal: An insider's revolt against out-of-control psychiatric diagnosis, DSM-5, Big Pharma, and the medicalization of ordinary life.* William Morrow & Co.
⇒ DSM-5이후 정상범위까지 질병으로 확장. 진단 기준은 점점 완화되며 경계선 사례까지 장애로 포함. 과잉 진단과 과잉치료 발생.

맥락적합성 - 감정이나 행동이 맥락에 비후어 적절한가. 애도는 사별이라는 명백한 외부의 사건에 대한 반응이다. 따라서 강한 슬픔, 무기력, 식욕 저하 등은 병리적인 것이 아니라 예상 가능한 반응이다. 즉 동일한 증상이라도 맥락 없이 발생하면 질병, 맥락에 부합하면 정상

시간 경과와 자연적 회복 가능성 - Frances는 정상 감정과 정신질환을 경과(course)로 구분한다. 정상 애도는 시간이 지나면서 자연적으로 완화되며, 파동처럼 오르내리지만 점진적으로 회복한다. 그에 반해 주요우울장애는 지속적이고 경직된 상태로 외부 요인과 무관하게 유지되거나 악화된다.

기능 손상과 자기개념 - 정상애도는 고통은 크지만 자기가치감이 유진된다. 사랑하는 사람에 대한 상실이 중심이 된다. 반면 주요우울장애는 자기 비난, 무가치감, 죄책감을 동반하며 전반적인 삶에 대한 부정적 평가가 주를 이룬다.

Saving_Normal_Academic.pdf

Wakefield JC, Horwitz AV, Schmitz MF. Are we overpathologizing the socially anxious? Social phobia from a harmful dysfunction perspective. Can J Psychiatry. 2005 May;50(6):317-9. doi: 10.1177/070674370505000604. PMID: 15999945.
⇒ 사회공포증은 사회불안의 과도한 형태일 수 있음. 불안은 적응적 반응이며 회피 또한 정상 범위의 본능.

Wakefield JC, Schmitz MF, Baer JC. Does the DSM-IV clinical significance criterion for major depression reduce false positives? Evidence from the National Comorbidity Survey Replication. Am J Psychiatry. 2010 Mar;167(3):298-304. doi: 10.1176/appi.ajp.2009.09040553. Epub 2010 Jan 15. PMID: 20080980.
⇒ 증상이 심하다고 해서 무조건 병인 것은 아님. 반드시 그 증상이 나타난 맥락(사별 등)을 살펴야 하며, 그렇지 않으면 수많은 정상인을 환자로 분류. 유해한 역기능

Spitzer, R. L., & Wakefield, J. C. (1999). "DSM-IV diagnostic criterion for clinical significance: Does it help solve the false positive problem?"
⇒ DSM의 '기능 손상' 기준이 오진을 줄여줄 것이라 기대했지만, 실제로는 판단자의 주관이 개입되어 오히려 진단 인플레이션을 부추긴다는 통계적 분석

반론

Kendler KS. Toward a philosophical structure for psychiatry. Am J Psychiatry. 2005 Mar;162(3):433-40. doi: 10.1176/appi.ajp.162.3.433. PMID: 15741457.
정신질환을 단순한 생물학적 결함이나 맥락적 불행으로 이분법적으로 보지 말고, 증상의 심화 과정 자체를 병리적 프로세스로 봐야 한다. 맥락이 있어도 증상이 선을 넘으면 병리다.

맥락은 객관적이지 않다. 애도와 우울은 하나의 연속선상이다. 애도도 병리적일수있다. 애도에서 우울증으로 강화되는 경우가 있으므로 초기진단에서는 알수없다.

Kendler, K. S., Myers, J., & Zisook, S. (2008). Does bereavement-related major depression differ from major depression associated with other stressful life events?. The American journal of psychiatry, 165(11), 1449–1455. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2008.07111757
우울증과 애도의 증상은 다를바 없다.